TESTDOKUMENT · Inte publicerat eller granskat av PM:ets författare · Sammanfattningen är gjord av Kjell Stefansson, inte av författarna

AKUT VESTIBULÄRT SYNDROM

Vuxna med akut yrsel • Central eller perifer • Handläggning

Akut debut med fokalneurologi: handlägg enligt Rädda hjärnan-rutinen (inom 24 timmar från symtomdebut: överväg Rädda hjärnan-larm). Uppmärksamma plötslig dysfagi, dysartri, diplopi och domningar. DT hjärna har mycket begränsad sensitivitet för infarkt i bakre cirkulationen. Källa s. 2, 6–7

01 BEDÖMNING STEG FÖR STEG

Källa s. 2–6, 9–10

1 · ALLMÄN BEDÖMNING: VP, EKG, ANAMNES, COR/PULM/NEUROSTATUS – OBS SKEW OCH HÖRSEL		
Nytt neurologiskt bortfall	→	**Rädda hjärnan-rutinen** – DT om strokemisstanke.
Akut nytillkommen ensidig hörselnedsättning vid AVS	→	**Central genes** (AICA-infarkt) – räknas som central bild på HINTS (HINTS+).
Ingen misstänkt vestibulär- eller CNS-orsak	→	**”Annan” orsak** – akut DT hjärna sannolikt ej värdeskapande.

2 · NYSTAGMUS? FRENZEL I RYGGLÄGE EFTER MINST FEM MINUTERS VILA (EJ ÄNDLÄGESNYSTAGMUS) – ETT ENDA CENTRALT FYND RÄCKER				
Riktningsväxlande, vertikal eller strikt torsionell	→	**Central genes.**		
Enkelriktad horisontell (mot friska sidan)	→	HIT patologiskt mot sjuka sidan (korrektionssackad) + normal skew	→	**Vestibularisneurit.**
		HIT **normalt** (ingen sackad), eller vertikal skew	→	**Central genes.**
Ingen nystagmus	→	Lägesprov positivt (paroxysmal positionsnystagmus)	→	**BPPV.**
		Lägesprov normalt	→	Gå till steg 3.

3 · SITTA, STÅ OCH GÅ		
Klarar inte utan stöd, eller nytt bortfall	→	**Central genes.**
Står och går ordentligt	→	**”Safe to go”** – akut DT hjärna sannolikt ej värdeskapande.

HIT = head impulse test. Lägesprov = Dix-Hallpike och supine roll test. HINTS gäller bara vid AVS: ihållande yrsel (inte attacker) med nystagmus.

TESTDOKUMENT Sammanfattning av Kjell Stefansson, inte av PM:ets författare

TESTDOKUMENT · Inte publicerat eller granskat av PM:ets författare · Sammanfattningen är gjord av Kjell Stefansson, inte av författarna

02 HANDLÄGGNING

Källa s. 2, 4, 6–10

CENTRAL GENES – SOM STROKE

- **Fokalneurologi:** Rädda hjärnan-rutinen.
- **Central bild på HINTS:** akut DT hjärna. Ingen blödning: ladda **ASA 300 mg (4 × 75 mg)** eller DAPT, vanligen ASA 300 mg + **klopidogrel 4 × 75 mg**.
- Lägg in på **strokeavdelningen 85B1**. **MRT efter 24 h** om stabil och annan diagnos inte misstänks.
- Rådgör med neurologjouren om bilddiagnostik – DT kan inte utesluta ischemisk genes.

VESTIBULARISNEURIT

- **Ingen bilddiagnostik krävs** (se dock DT-indikationer nedan). Kortison rekommenderas inte.
- Kraftigt illamående: antiemetika, ev. vätska iv. **Vestibulär träning** så tidigt som möjligt.
- **Säker diagnos:** hem med remiss till fysioterapin (Akademiska).
- Svår yrsel, kan inte gå hem: **ÖNH-jour** (inläggning ÖNH).
- Kan inte sitta, stå eller gå utan stöd: talar starkt för central genes (ses även vid svår neurit) – DT-indikation.

BPPV

- Dix-Hallpike positiv: **Epleys manöver**.
- Supine roll positiv: **Gufonis manöver**.
- Utvärdera efter ca 1 timme. Flera båggångar: ÖNH-jour kan kontaktas.
- Uppföljning: primärvård eller fysioterapin.

- **Osäker diagnos: neurologjouren**. **Yrsel + ont i örat: ÖNH-jouren** (labyrintit). **Misstänkt Menière:** ÖNH-jour.
- **DT hjärna bara vid:** central bild på HINTS och/eller oförmåga att sitta, stå eller gå utan stöd · fokalneurologi · misstänkt dissektion (särskilt yngre med huvud- eller nackvärk – lägg då till **DT-angiografi** av halsens och hjärnans artärer) · blödningsrisk (antikoagulantia, hjärnmetastaser, trauma). DT-angiografi i övrigt bara vid Rädda hjärnan, misstänkt halskärlsdissektion (t.ex. unilateral smärta) eller basilaristrombos (t.ex. kranialnervsbortfall). **MRT kan vara falskt negativ de första 48 timmarna.**
- **Remisstext vid central bild:** ”Patient med akut vestibulärt syndrom. HINTS-status talar för central genes. Misstanke om ischemisk stroke i bakre cirkulationen.”

⚠ **PM:et otydligt:** anger inte om central bild på HINTS utan fokalneurologi, inom 24 timmar från debut, ska larmas som Rädda hjärnan.

TESTDOKUMENT
Sammanfattning av Kjell Stefansson – inte av PM:ets författare

Region Uppsala: ”Akut vestibulärt syndrom”.
DocPlusSTYR-46930 · version 2 · godkänt 2026-06-10.
Via akutkompassen.se/#pm=46930 · hämtat 2026-10-15.
Original-PM (DocPlus)
⚠ = punkt där PM:et självt är otydligt.

OM SAMMANFATTNINGEN

Detta är en sammanfattning av det angivna källdokumentet, genererad av Kjell Stefansson, ST-läkare i akutsjukvård, med hjälp av AI. Sammanfattningen ersätter inte originaldokumentet. Kontrollera aktuell version och lokal tillämplighet.